

RECURSO CÍVEL Nº 5009351-94.2024.4.02.5102/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRIDO: ARINETH ALVES BATISTA (AUTOR)
RECORRIDO: JOSE MAURICIO PINHO (AUTOR)

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SERVIÇO DE HEMATOLOGIA E INVESTIGAÇÃO DE NEOPLASIA. AUTOR AGUARDANDO EM FILA DO SISREG DESDE AGOSTO DE 2024. PARECER DO NAT CONCLUI PELA IMPRESCINDIBILIDADE DA TRANSFERÊNCIA. TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ANTONIO PEDRO NO CURSO DO PROCESSO. REDE DE ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a parte recorrente vencida em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Intime-se o Ministério Público Federal. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5009351-94.2024.4.02.5102

510015181149 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5009351-94.2024.4.02.5102/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRIDO: ARINETH ALVES BATISTA (AUTOR)
RECORRIDO: JOSE MAURICIO PINHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

"[...]"

*No caso dos autos, o requerimento de tutela de urgência foi deferido ao Evento 22, determinando a transferência da parte autora para **Hospital Terciário com Serviço de Hematologia.***

No Parecer de Evento 66, o NAT informou que a parte autora havia sido transferida para o Hospital Universitário Antônio Pedro, habilitado na Rede de Alta Complexidade Oncológica.

Intimada, a parte autora confirmou a informação do NAT e requereu a procedência dos pedidos.

No caso dos autos, a transferência da parte autora, pedido dos autos, ocorreu em razão de decisão deste Juízo.

Portanto, sob os mesmos fundamentos, a decisão de Evento 22 deve ser ratificada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para ratificar a tutela de urgência concedida que determinou a transferência da parte autora para hospital especializado, apto a dar prosseguimento ao seu tratamento."

Sustenta a Recorrente, de forma genérica, que o Sistema Único de Saúde, na hipótese dos autos, ainda está operando dentro do prazo legal previsto na Lei n.º 12.732/2012.

Alega que o princípio da isonomia deve ser respeitado, não cabendo ao Poder Judiciário determinar quem será tratado em primeiro lugar, não sendo possível o custeio do tratamento em unidades privadas de saúde.

Na eventualidade de manutenção da procedência do pedido, requer que o cumprimento seja direcionado ao Estado ou Município

na eventual procedência do pedido, pretende que seja direcionado o cumprimento ao Estado ou Município e que todo o ônus financeiro seja custeado igualmente pelos corréus no caso de tecnologias não incorporadas pelo SUS.

Por fim, requer o estabelecimento de honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável.

VOTO

I - Do Direito a Saúde e o RE 855.178

Considerando o julgamento, sob o crivo da repercussão geral, pelo STF no RE 855.178, que reafirmou que a solidariedade dos entes no fornecimento do tratamento adequado aos necessitados se insere no rol de deveres do Estado, passo a adotar tais premissas no julgamento dos recursos em face de sentença e agravo sobre o tema. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (STF , RE 855.178, Min Luiz Fux, Publicado em 16/3/2015)

Ficaram vencidos, no mérito, os Ministros Teori Zavascki, Roberto Barroso e Marco Aurélio.

Destaco que foi também reconhecida no STF repercussão geral no RE 566.471- RG, relatoria do Ministro Marco Aurélio, no qual se debate o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave, que não possui condições financeiras para comprá-lo. Matéria que, em regra, ante a limitação de alçada do Juizado, encontra-se fora da competência deste.

Portanto, a discussão acerca da legitimidade passiva da União decidida em sede de repercussão geral deve ser adotada.

Destacou ainda o Ministro:

“O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.”

“.....Bem delimitado o tema, verifica-se que o Tribunal de origem, ao assentar a responsabilidade solidária da União, “não destoou da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte”, no julgamento da Suspensão de Segurança (SS) 3355, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. ...”

De acordo com o voto condutor, o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência atual do STF, sobre o tema, também tem registrado questão da possibilidade de substituição do medicamento/cirurgia pretendido(a) por alternativa padronizada. E, sobre o tema, trago à baila recente decisão do STF que suspende decisão judicial que determinava a realização de cirurgia sem demonstração de necessidade e ineficácia de alternativas. Vejamos:

“Quinta-feira, 08 de janeiro de 2015

Custeio de cirurgia exige demonstração de necessidade e ineficácia de outras alternativas

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, determinou a suspensão de decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) que havia obrigado o Município de Maceió a custear procedimento médico conhecido como artroscopia, no valor de R\$ 41 mil. Segundo o ministro, desde decisão anterior da Corte em caso semelhante, entendeu-se que não ficou demonstrada a necessidade de realização do procedimento médico nem a busca por alternativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o ministro Ricardo Lewandowski, a decisão da Justiça local representa uma ameaça de grave lesão à ordem e à economia públicas. Ao decidir, o presidente do STF relatou que o caso questionado pelo município se amolda a decisão anterior do STF, já proferida na própria Suspensão de Tutela Antecipada (STA) 748, e determinou a extensão de seus efeitos ao novo caso enfrentado pela administração da capital de Alagoas.

O tema em debate na decisão original da STA 748 é análogo ao veiculado no pedido atual do município. “Os princípios da economicidade e da eficiência justificam o acolhimento do pleito ora formulado pelo Município de Maceió”, afirmou o ministro Lewandowski, deferindo sua extensão para a suspender os efeitos de decisão proferida pelo TJ-AL, a qual havia mantido o bloqueio de R\$ 41.396,59, determinado pelo juízo da 14ª Vara Cível de Maceió para garantir a realização da cirurgia.

Pedido de extensão

O Município de Maceió argumentou em seu pedido de extensão de decisão que, semelhantemente ao caso original, não houve a demonstração de necessidade de realização de uma cirurgia de artroscopia de ombro em detrimento de outros tratamentos fornecidos pelo sistema público. No caso original decidido pelo STF (STA 748), também relativo àquela municipalidade, foi determinada a suspensão de ordem judicial que determinava a realização de um procedimento de estimulação magnética transcraniana em um outro paciente, ao custo de R\$ 68 mil. Segundo o entendimento da presidência do Supremo à época, as provas não confirmaram o caráter urgente do procedimento nem evidenciaram a busca prévia por alternativas oferecidas pelo SUS.”

II - Do Caso Concreto:

Narra o Autor, na inicial, encontrar-se internado no Hospital Municipal Carlos Tortely e necessitar, com urgência, de transferência para unidade hospitalar que forneça tratamento oncológico. Esclarece estar inscrito no SISREG desde 28/08/2024 (evento 1, ANEXO2, fl. 04) e que apresenta risco de morte caso a transferência não seja efetuada.

DADOS DO SOLICITANTE		
NOME DO ESTABELECIMENTO SOLICITANTE HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELY		CNES 0012513
Nº DA SOLICITAÇÃO 5853079	ESTADO ATUAL Em fila	DATA DA SOLICITAÇÃO 29/08/2024
MOTIVO		
JUSTIFICATIVA PACIENTE INTERNA POR FEBRE E ODINOFAGIA, COM PANCITOPENIA SEVERA. SÍNDROME MIELODISPLÁSICA A		
PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS ANEXADO		
CONDIÇÕES QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO ACIMA		
PRINCIPAIS RESULTADOS DE PROVAS DIAGNÓSTICAS (RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS)		
OBSERVAÇÕES		
PROCEDIMENTO SOLICITADO		
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO		CÓDIGO DO PROCEDIMENTO 0304100021
NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE/ASSISTENTE SORAYA TANUS		
Nº DOCUMENTO CPF DO PROFISSIONAL SOLICITANTE/ASSISTENTE		
AUTORIZAÇÃO		
Autorizado por:		CPF:
Data Autorização:		

Conforme laudo médico de 04/09/2024, o Autor necessita de transferência para hospital terciário com serviço de hematologia para elucidação diagnóstica de neoplasia e posterior tratamento, havendo risco de morte e danos irreversíveis em sua saúde (evento 1, ANEXO2, fl. 14).

RELATÓRIO MÉDICO

PACIENTE: JOSE MAURICIO PINHO
BOLETIM DE ATENDIMENTO: 7839

JOSE MAURICIO PINHO, 63 ANOS, SEM COMORBIDADES PREVIAS, INTERNA EM 26/08 NESTE NOSOCOMIO, DEVIDO A QUEDA DO ESTADO GERAL, FRAQUEZA, FEBRE E ODINOFAGIA A ESCLARECER. EXAMES LABORATORIAIS SUCESSIVOS E REPETIDOS MOSTRAM PANCITOPENIA MODERADA PROVAVELMENTE POR SINDROME MIELODISPLASICA (NEOPLASIA ??). AVALIADO PELO HEMATOLOGISTA PARECERISTA DO HMCT, REGULADO PARA TRANSFERENCIA PELO SER ESTADUAL EM 29/08 - NUMERO DE INSCRIÇÃO 5853079. O PACIENTE NECESSITA DE TRANSFERENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAL TERCIARIO COM SERVIÇO DE HEMATOLOGIA ATUANTE PARA ELUCIDACAO DIAGNOSTICA E TRATAMENTO. INFORMO QUE A MOROSIDADE NA TRANSFERENCIA PODE TRAZER DANOS IRREVERSIVEIS A SAUDE DO PACIENTE, INCLUINDO RISCO DE MORTE. CID D46

Parecer do NAT ressaltou que o médico assistente solicitou a transferência para hospital com serviço de hematologia, sendo o mesmo indicado e imprescindível ao manejo quadro clínico do Autor (evento 18, PARECER1).

Desta forma, em 09/09/2024, deferida parcialmente a tutela para que o Autor fosse transferido para hospital terciário com serviço de hematologia, de acordo com a ordem de preferência em fila de pacientes que aguardavam tratamento (evento 22, DESPADEC1).

O Ministério Público Federal se manifestou quanto à parcial procedência do pedido, apenas para a transferência do Autor para unidade hospitalar especializada no tratamento de hematologia (evento 45, PARECER1).

Conforme documentos colacionados aos autos, o Autor foi transferido para Hospital Universitário Antônio Pedro, em 25/09/2024 (evento 66, PARECER1), para tratamento oncológico (evento 73, PET1) (evento 74, ANEXO3).

O paciente foi inserido no Sistema Estadual de Regulação - SER pela unidade solicitante Hospital Municipal Carlos Tortelly em 29/08/2024. Durante este período foram encaminhadas solicitações de vagas para os Hospitais referenciados nas redes federal e estadual, das quais recebemos respostas negativas em decorrência da falta do leito.

Segundo informação inserida no Sistema Estadual de Regulação (SER), o paciente foi transferido e internado no Hospital Universitario Antonio Pedro em 25/09/2024 às 11h28min.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o parecer do NAT concluiu pela imprescindibilidade da transferência do Autor para hospital com serviço de hematologia, sendo a tutela de urgência deferida neste sentido e em observância à ordem de preferência da fila de pacientes e gravidade do caso.

Não há que se falar em direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado ou ao Município, posto que o Autor encontra-se internado em hospital federal de alta complexidade cuja competência também é da União Federal.

No que tange ao arbitramento dos honorários, não há que se falar em apreciação equitativa, uma vez não configurada a hipótese do art. 85, §8º do CPC, mas sim do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ressalto não estarmos diante de procedimento de jurisdição voluntária, mas sim de contencioso cível e que a tese de arbitramento por equidade não tem sido aceita pelo STJ ainda que se tratasse de demanda sob o rito ordinário, o que tampouco é o caso.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portador de adenocarcinoma de próstata contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento XTANDI 40ing (ENZALUTAMIDA), na quantidade de cento e vinte comprimidos por mês, por tempo indeterminado. Foi dado à causa o valor de R\$ 148.499,04 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos - válidos para novembro de 2017), que corresponderia ao valor do tratamento médico prescrito em favor da parte autora, pelo período de 12 (doze) meses.

2. O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a fornecer o medicamento pleiteado na inicial, por seu respectivo princípio ativo, conforme prescrição médica, sem preferências por marcas, e enquanto durar o tratamento. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários fixados em R\$ 1.000 reais.

3. A Apelação da parte autora para majorar os honorários advocatícios não foi provida. Ao exercer o juízo de retratação, em virtude do julgamento do tema 1.076 pelo STJ, o Tribunal de origem manteve o aresto vergastado pelos seguintes fundamentos: "In casu, infere-se de singela leitura do v. acórdão de fls. 188/195, que, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade não conflita com os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.076 do STJ que, modificando orientação anterior, passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo e que o artigo 85, § 8º, da lei adjetiva de 2015, seria utilizado apenas em caráter excepcional, contudo, a mesma Corte assentou entendimento no sentido de que nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação **equitativa**, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável".

4. **A irresignação prospera porque a Corte Especial do STJ, em hipótese análoga, de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, §8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família:** AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, Dje de 27.9.2022.

5. **Recurso Especial provido, com o retorno dos autos à Corte de origem para fixação do valor da verba honorária.** (REsp n. 2.060.919/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, Dje de 28/6/2023.)

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação, **VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**. Condene a parte recorrente vencida em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Intime-se o Ministério Público Federal. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem.

5009351-94.2024.4.02.5102

510015181148 .V9